Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
1ª Vara Cível da Comarca de Carazinho

Rua Bento Gonçalves, 151 - Bairro: Vargas - CEP: 99500000 - Fone: (54)3046--9878 - Email: frcarazinh1vciv@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5007160-02.2023.8.21.0009/RS

AUTOR: ODALGIR MEDEIROS

RÉU: IPE-SAÚDE - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO RIO GRANDE DO SUL

SENTENÇA

1. Relatório

Odalgir Medeiros ajuizou a presente ação de obrigação de fazer em face do Instituto de Assistência a Saúde dos Servidores Públicos do Rio Grande do Sul - IPE Saúde.

Narra a inicial que o autor é servidor público, beneficiário do IPE Saúde e foi diagnosticado com "neoplasia no rim direito carcinoma de células claras grau 3", sendo indicado o tratamento com o medicamento Pembrolizumabe 100mg/ml, duas ampolas, a cada 21 dias.

Refere que, em 24 de julho de 2023, o réu "emitiu a a Guia de Autorização (G.A. nº 20230701), datada em 24/07/2023 (em anexo) tendo como situação “NÃO AUTORIZADA”". Menciona que a negativa fundamenta-se na ausência de cobertura pelo plano.

Tece comentários sobre o direito que ampara a pretensão, destacando a urgência do uso do medicamento.

Requer, em tutela de urgência antecipada, seja determinado que o réu forneça o medicamento Pembrolizumabe 200mg/ml, a cada 21 dias.

Pugna pela procedência da ação e pede a concessão da Justiça gratuita.

Deferida a tutela de urgência e concedida a Justiça gratuita, evento 3, DESPADEC1.

Citado, o réu apresentou contestação em evento 15, CONT1.

Sustenta, em síntese, que o procedimento pleiteado pelo autor não consta no Protocolo Oncológico adotado pelo IPE Saúde para o tratamento da enfermidade do autor.

Refere que possui um protocolo oncológico elaborado pela Sociedade de Cancerologia do Rio Grande do Sul, o qual prevê quais medidas devem ser utilizadas em cada neoplasia, nos diferentes estágios e tratamentos. Enfatiza que não pode ser compelido à cobertura de um tratamento que excede o previsto por seu regulamento, de custo elevado, sob pena de ser levado à insolvência, prejudicando a coletividade associada

Aduz que não há evidência científica de que o medicamento é seguro e eficaz, bem como não integra a tabela de cobertura do IPE Saúde.

Enfatiza que o medicamento Pembrolizumabe (KEYTRUDA) não está previsto na Instrução Normativa IPE Saúde n° 02, de 27 de abril de 2021, a qual institui as Diretrizes de Cobertura dos Tratamentos Oncológicos do Sistema IPE Saúde. Entretanto, para tratamento de neoplasia maligna do rim estão disponíveis os outros medicamentos.

Pugna pela improcedência do pedido.

Réplica em evento 19, RÉPLICA1

Instadas as partes sobre as demais provas que pretendia produzir, o réu requereu o julgamento antecipado (evento 25, PET1) e o autor silenciou.

Fez-se conclusão do processo para julgamento.

É o relatório.

Decido.

2. Fundamentação

Em resumo do apurado durante as fases postulatórias e instrutórias, considerando a amplitude da cobertura, encontrando fundamento legal a responsabilidade do réu em promover todos os atos necessários ao fornecimento do tratamento médico postulado e embasado em laudo pericial fundamentado, afirma-se que a melhor conclusão é de que a parte autora faz *jus* ao tratamento de saúde perseguido, com algumas ressalvas.

Nos termos da Lei Complementar Estadual nº 12.134/2004, que regulamenta o IPÊ-Saúde, integram o plano de saúde atendimentos médicos, hospitalares e atos necessários ao diagnóstico e tratamento, bem como ações de prevenção da doença e promoção da saúde, nos termos do seu art. 2º.

O artigo 4º, §1º, da Lei Complementar Estadual n. 15.145/2018, que dispõe sobre o Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Rio Grande do Sul – Sistema **IPE** Saúde, tem a seguinte redação:

> *Art. 4.º O Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Rio Grande do Sul – Sistema IPE Saúde – consiste na cobertura das despesas decorrentes dos procedimentos previstos em tabelas próprias do Instituto para atendimento médico, hospitalar, ambulatorial, laboratorial, bem como dos atos necessários ao diagnóstico e aos tratamentos devidos aos usuários, na forma estabelecida nesta Lei Complementar e em resoluções do Órgão Gestor.*
>
> *§ 1.º Ficam excluídos da cobertura do IPE Saúde os procedimentos, exames, tratamentos, insumos, materiais, que não estejam previstos nas tabelas próprias do Instituto.*

Essa disposição legal modificou o panorama até então existente, já que, sob a vigência da Lei Complementar n. 12.134/04, a jurisprudência formou-se no sentido de que o critério que definia a cobertura do IPÊ-SAÚDE era o da exclusão expressa (entendiam-se cobertos todos os procedimentos necessários, salvo previsão expressa de exclusão). Agora, com a entrada em vigor da Lei Complementar Estadual n. 15.145/2018, sustenta-se que o critério inverteu-se, abrangendo agora o da previsão expressa (exclusão dos procedimentos não previstos nas tabelas próprias do Instituto).

A alteração legislativa referida provoca, na visão deste juízo, uma enorme divergência jurídica, na medida em que, não obstante haja a oferta de um produto em mercado de consumo (ainda que restrito), submeteu-se o segurado a regramento diametralmente oposto aos chamados planos de saúde privados.

Não se olvida a existência de posição que sustenta uma natureza jurídica diversa do IPÊ-SAÚDE à dos planos de saúde privados; questiona-se, porém, argumentativamente, qual a razão jurídica do discrímen, haja vista que o IPÊ-SAÚDE é igualmente formado pela facultatividade (artigo 3º - autonomia privada, liberdade para contratar), pela onerosidade (artigo 2º, §1º - característica do sinalagma), com a contraprestação de serviços saúde (artigo 2º, caput) cobertos em decorrência de uma *ratio* autuarial (artigo 4º, caput e §2º, além de artigos 36 e seguintes), oferecido em concorrência (mercado), nos exatos moldes dos planos de saúde privados.

Talvez, a melhor compreensão constitucional da questão, haja vista a competência legislativa concorrente (artigo 24, incisos V e VIII, da CRFB/88) e as regras da concorrência (artigo 173, §1º, II), seja a de que o IPÊ-SAÚDE submete-se, igualmente, às regras da legislação consumeirista e dos planos de saúde privados, ressalvada a competência suplementar às normas gerais editadas pela União (artigo 24, §§1º e 2º, CRFB).

De todo modo, a divergência sobre a submissão do IPÊ-SAÚDE a um regime predominantemente público ou privado, muitas vezes, não provoca efeitos definitivos sobre um juízo de probabilidade do direito, pois, em ambos, tem-se garantido, *mutatis mutandis*, os meios necessários para a garantia do direito constitucional à saúde, de acordo com as diretrizes do médico assistente.

Vejamos.

No âmbito dos planos de saúde privados, é tranquila a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "à luz do Código de Defesa do Consumidor, devem ser reputadas como abusivas as cláusulas que nitidamente afetam de maneira significativa a própria essência do contrato, impondo restrições ou limitações aos procedimentos médicos, fisioterápicos e hospitalares (v.g. limitação do tempo de internação, número de sessões de fisioterapia, entre outros) prescritos para doenças cobertas nos contratos de assistência e seguro de saúde dos contratantes" (AgInt no REsp n. 1.349.647/RJ, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 23/11/2018).

Igualmente, há inúmeros precedentes daquele Sodalício com a posição de que "o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura. Desse modo, entende-se ser abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, medicamento ou procedimento imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário (AgInt no AREsp 1577124/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 04/05/2020). E que "a lei estabelece que as operadoras de plano de saúde não podem negar o fornecimento de órteses, próteses e seus acessórios indispensáveis ao sucesso da cirurgia, como por exemplo a implantação de stents ou marcapassos em cirurgias cardíacas. Se o fornecimento de órtese essencial ao sucesso da cirurgia deve ser custeado, com muito mais razão a órtese que substitui esta cirurgia, por ter eficácia equivalente sem o procedimento médico invasivo do paciente portador de determinada moléstia" (REsp 1.731.762/GO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 28/5/2018).

No âmbito do regime de direito público, outrossim, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 106 (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018), reconheceu a existência do direito ao cidadão a prestações de saúde não previstas nos protocolos clínicos, submetido a algumas condicionantes. Entre tais condições, "(i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS". Observe-se que, mais uma vez, privilegia-se o tratamento recomendado pelo médico assistente.

A tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no precedente supracitado condiz com as conclusões do Supremo Tribunal Federal na STA 175, Relator Ministro Gilmar Mendes, em que, depois de realizadas audiências públicas, concluiu-se que a omissão administrativa da atualização das listas de dispensação públicas não constituiria óbice legítimo ao acesso do cidadão ao direito à saúde.

Por todo o exposto, concluiu-se que, independentemente da natureza jurídica do IPE-SAÚDE, seja predominantemente privada ou pública, existe, em abstrato, a probabilidade de se superarem negativas que limitam o direito ao acesso à saúde pelo segurado. Por isso, ainda que com fundamentos diversos, há precedentes das Turmas Recursais e do

Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul:

Ementa: RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. IPÊ-SAÚDE. FORNECIMENTO DE ÓRTESE – NEUROFISIOLÓGICA DE ELETROESTIMULAÇÃO FUNCIONAL DINÂMICA (WALKAIDE SYSTEM IMPORTADA). NEGATIVA ADMINISTRATIVA DE COBERTURA. VEDAÇÃO DE LIMITAÇÃO À PRERROGATIVA DE ESCOLHA DO TRATAMENTO PELO MÉDICO. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. A despeito das novas determinações da legislação complementar vigente, a ausência de previsão nas tabelas próprias da autarquia não deve figurar enquanto obstáculo ao fornecimento do insumo médico postulado. Isso porque demandas judiciais que dizem respeito à concretização do direito à saúde, por óbvio, exigem apreciação atenta às especificidades do caso concreto, porquanto não são homogêneos e idênticos os quadros clínicos, assim como não poderiam ser também idênticas as prescrições médicas. A restrição da prerrogativa médica de escolha do tratamento mais adequado ao seu paciente é conduta expressamente vedada pelo Código de Ética Médica. Não bastasse isso, as diretrizes do plano de saúde não podem representar empecilho para que o cidadão goze dos direitos fundamentais consignados constitucionalmente. RECURSO INOMINADO PROVIDO. UNÂNIME.(Recurso Cível, Nº 71008548505, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Maria Beatriz Londero Madeira, Julgado em: 26-09-2019)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. IPE-SAÚDE. ESTENOSE AÓRTICA GRAVE. CIRURGIA DE IMPLANTE VALVAR TRANSCATETER COM PRÓTESE EVOLUT. LEI COMPLEMENTAR 15.145/2018. RESOLUÇÃO Nº 311/2012. DEVER DE FORNECIMENTO NÃO APENAS DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO COMO TAMBÉM DOS MATERIAIS INDICADOS PELA EQUIPE MÉDICA QUE ASSISTE O AUTOR. AUSENTE COPARTICIPAÇÃO EM CIRURGIA. 1. Inicialmente, considerando que a negativa administrativa restou realizada após a entrada em vigor da Lei Complementar nº 15.145/2018 (inexistente prova do pedido), aplicável a novel legislação ao caso em tela. 2. Procedência da demanda quanto ao fornecimento do procedimento cirúrgico acobertada pela preclusão, eis que inexistente irresignação recursal pelo IPE-Saúde. Cinge-se o recurso, pois, à obrigação da autarquia ao fornecimento da prótese Evolut, o que acarretou na determinação de que o autor ressarça a diferença entre o material efetivamente utilizado em decorrência da tutela de urgência e a prótese disponibilizada pelo plano de saúde, além da coparticipação do segurado no procedimento. 3. Da observância dos autos, constata-se que o demandante, segurado do IPÊ-Saúde, restou diagnosticado com cardiopatia grave (CID I 350) em decorrência de estenose de valva aórtica descompensada. Além da patologia valvar, apresenta hipertensão arterial sistêmica e história de cistocospia, havendo indicação médica, sob risco de morte súbita, para realização de cirurgia de implante valvar aórtico transcateter (TAVR/TAVI), por via transfemoral com prótese Evolut, para tratamento de estenose aórtica grave. O laudo médico colacionado ao feito e subscrito pelo Chefe do Serviço de Hemodinâmica do Hospital São Francisco e pelo Cirurgião Cardiovascular, Diretor Médico do mesmo nosocômio é expresso quanto à necessidade do procedimento e da utilização do material apontado, devido às especificidades do quadro clínico do paciente. 4. Os pareceres emitidos pela perícia pública, no mais das vezes sem qualquer contato com o paciente, não têm o condão de mitigar a indicação médica emitida pelo profissional que o acompanha. De regra, não há que se atender a estudos e sugestões de substituição de tratamento em detrimento da indicação realizada pelo médico que trata pessoalmente do paciente, pois o escopo preponderante da administração pública, na espécie, é o barateamento do tratamento e o almejo maior do médico que atende seu paciente é o melhor para sua saúde. Consigna-se que embora possam eventualmente inexistir evidências científicas a embasar que a prótese indicada seja a única possível, não se há de relevar a hipótese, tampouco indicado qual prótese poderia ter sido utilizada em seu lugar, com ou sem estudos para tanto. A evidência científica de eficácia ostenta uma feição cartesiana, que faz admitir apenas o que se apresente indubitável. Tal segurança, em medicina, dificilmente se atinge, daí porque exsurge, simplesmente, com a autorização da prescrição do tratamento ou procedimento pelos respectivos órgãos de fiscalização e regulação e a qualificação profissional de quem o prescreve. Para o correto deslinde do feito, deve-se atender a princípios constitucionais, ajustando-os à ideia de colocar a vida e a saúde como supravalores, que reclamam os mais modernos e menos danosos meios à sua conservação. 5. Embora o art. 4º da Lei Complementar nº 15.145/18, que revogou a Lei nº 12.134/04, disponha que integram o plano de saúde atendimentos médicos, hospitalares, ambulatoriais, laboratoriais, bem como atos necessários ao diagnóstico e aos tratamentos, exceto os tratamentos não previstos nas tabelas do próprio Instituto, o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte é cristalino quanto à impossibilidade do plano de saúde eleger as espécies de tratamento fornecidos ao segurado. Logo, descabe interpretação restritiva, pois a responsabilidade quanto ao fornecimento do procedimento indicado, bem como seus materiais, a fim de possibilitar o tratamento ao paciente - segurado, está atrelada ao que dispõe o referido art. 2° da Resolução nº 21/1979, ou seja, "os atos necessários ao diagnóstico ou tratamento". Demais, a fundamentalidade do direito à saúde faz com que sua garantia seja a expressão de resguardo da própria vida – maior bem de todos –, do qual a generalidade dos demais direitos se há de extrair o sentido. A prova constante dos autos dá conta da real necessidade médica do demandante – segurado do Instituto, sendo imperiosa a procedência da ação não apenas quanto ao fornecimento da intervenção cirúrgica pleiteada, como também quanto aos materiais requeridos. 6. Nessa esteira, inexiste dever de coparticipação no que tange ao procedimento cirúrgico, conforme a própria autarquia confirma em suas contrarrazões recursais, havendo previsão na Resolução nº 311/2020 apenas quanto à participação em exames e consultas. Destarte, a sentença deve ser reformada a fim de que seja julgada procedente a demanda, sem qualquer espécie de ressarcimento ou coparticipação por parte do autor. 7. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, o Código de Processo Civil de 2015 fixou percentuais específicos para o arbitramento de honorários. No entanto, as ações relacionadas a medicamentos devem ser tratadas como de valor inestimável, pois os bens almejados são a vida e a saúde e não apenas o fornecimento em si e o respectivo valor do fármaco ou tratamento, inexistindo acréscimo patrimonial em favor da parte autora. Sendo assim, a fixação dos honorários advocatícios, por apreciação equitativa, com base no art. 85, § 8°, do Código de Processo Civil, para a hipótese contida nos autos, mostra-se plenamente adequada, não se havendo falar em proveito econômico para fins de justificar o arbitramento da verba com fulcro no art. 85, § 3°, do Código de Processo Civil. Sob esse prisma, sem razão o apelante quando pugna pela fixação dos honorários em percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa. No entanto, considerando que o presente resultado confere julgamento de procedência da ação, necessário redimensionar a condenação honorária. Fixada a verba honorária com observância dos parâmetros do art. 85, §2º, do Diploma Processual Civil. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 70084435221, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Julgado em: 30-09-2020)

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. TRATAMENTOS DE FISIOTERAPIA, HIDROTERAPIA E EQUOTERAPIA. DEVER DE FORNECIMENTO DO IPÊ-SAÚDE. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO MÉDICA EM RELAÇÃO AO TRATAMENTO DE FONOTERAPIA. IMPOSSIBILIDADE DE FORNECIMENTO. QUESTÃO ATINENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO TRATAMENTO JÁ REALIZADO NÃO CONHECIDA, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES DESTA CORTE. 1. No caso vertente, há nos autos prescrição médica que valida o fornecimento dos tratamentos de fisioterapia, hidroterapia e equoterapia, sob pena de aumentar o risco de progressão de doença e consequente piora da qualidade de vida do autor. 2. Em que pese o §1º do art. 4º da Lei Complementar nº 15.145/2018 exclua expressamente da cobertura do IPE Saúde os procedimentos, exames, tratamentos, insumos e materiais que não estejam previstos nas tabelas próprias do instituto, no caso em concreto não é possível a limitação de tratamento pelo plano de saúde. A cobertura se dá em razão da patologia, não podendo haver restrição quanto ao tratamento, cuja responsabilidade é do médico que acompanha o autor. 3. Desse modo, tem o agravante, na condição de segurado do agravado, o direito de recebê-los, visto que à referida autarquia compete propiciar aos seus beneficiários os atos necessários ao diagnóstico e ao tratamento de seus segurados. Em reforço, destaca-se que a Constituição Federal assegura a todos o direito à saúde, o que, no caso dos autos, deve ser concretizado por meio do IPE-SAÚDE. 4. Por outro lado, não merece reparos a decisão a quo em relação ao fornecimento do tratamento de fonoterapia, tendo em vista que não há nos autos, qualquer comprovação de prescrição médica indicando o referido tratamento ao agravante. 5. Ademais, denota-se que a questão atinente ao

ressarcimento de despesas do tratamento já realizado não restou analisada no Juízo a quo, o que impossibilita a análise nessa esfera de jurisdição sob pena de supressão de instância. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.(Agravo de Instrumento, Nº 70083761023, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Silveira Difini, Julgado em: 02-07-2020)

No caso, o autor é portador de "neoplasia de rim direito carcinoma de células claras grau 3", necessitando, atualmente, de tratamento com o medicamento Pembrolizumabe, conforme aponta o atestado elaborado pela médica que acompanha o autor (evento 1, ATESTMED5).

Atestado:

Referente a situação de saúde do paciente Odalgir Medeiros portador da patologia Neoplasia de rim direito carcinoma de celulas claras grau 3 pT3aNxM0 EC III, teve indicação Pembrolizumabe adjuvante para sua patologia por se encaixar nos critérios de alto risco de recidiva que foi negado pelo seu convênio médico, apesar do respaldo da literatura, aprovação pela ANVISA e no Roll da ANS (órgão que regula o sistema privado no país).

No momento, está em boas condições clinicas, performace clínica 0 e deve, urgentemente, iniciar tratamento oncológico com o tratamento solicitado, pela intenção curativa do seu tratamento.

A medicação proposta é chamada Pembrolizumabe aplicado por via intravenosa a cada três semana isolado por 12 meses.

A justificativa para o uso da medicação, baseia-se no estudo keynote 564

J Clin Oncol 39:abstr LBA5, 2021].

Ressaltando ser um estudo com validade externa fase III, demonstrando controle da doença a longo prazo e uma evolução mais favorável com aumento da sobrevida global.

Deve-se evitar postergar o inicio do uso do medicamento, já que esse atraso pode ter impacto adverso na sobrevida dos pacientes e aumentar sua chance de progressão de doença.

A paciente vai necessitar de 200 mg de Pembrolizumabe a cada 21 dias.

Passo Fundo, 24 de Julho de 2023.

Extrai-se do documento que a medicaçãoPembrolizumabe é indicada ao autor diante do alto risco de recidiva.

A indicação da médica do autor, que analisa o caso e tem conhecimento das particularidade do caso, não pode sucumbir diante de afirmação em abstrato de possibilidade de utilização de medicamento diverso ou da não recomendação de uso do fármaco requerido.

Em termos semelhantes, cito julgado do TJRS:

Ementa: *APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO (PÚBLICO). DIREITO À SAÚDE. PORTADORA DE NEOPLASIA MALIGNA DE MAMA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - VERZENIOS (ABEMACICLIBE). NEGATIVA DE COBERTURA ADMINISTRATIVA PARA FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE DO PLANO IPÊ - SAÚDE. APLICABILIDADE DA LEI Nº 15.145/18. PRESCRIÇÃO MÉDICA. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. CONFORME PRECONIZA A LEI COMPLEMENTAR N.º 15.145/2018, APLICÁVEL AO CASO EM ANÁLISE, O PLANO IPE-SAÚDE É INTEGRADO PELOS ATENDIMENTOS MÉDICOS, HOSPITALARES, ENVOLVENDO OS ATOS NECESSÁRIOS AO DIAGNÓSTICO E AO TRATAMENTO, BEM COMO AÇÕES DE PREVENÇÃO DA DOENÇA E À PROMOÇÃO DA SAÚDE. INEGÁVEL, ASSIM, A RESPONSABILIDADE DE CUSTEIO INTEGRAL DO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO. 2. A ESCOLHA DO MEDICAMENTO E DO TIPO DE TRATAMENTO A SER PRESCRITO AO PACIENTE CABE AO MÉDICO E NÃO AO CONVÊNIO, POIS, SOMENTE O PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PODERÁ OPTAR E RECOMENDAR QUAL O MELHOR MÉTODO E/OU MEDICAMENTO A SER UTILIZADO EM CADA CASO, TUDO NO OBJETIVO DE ALCANÇAR O MELHOR RESULTADO DO TRATAMENTO. 3. HONORÁRIOS RECURSAIS ESTABELECIDOS. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível, Nº 50007976220228210064, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em: 15-02-2023)*

Ementa: *APELAÇÕES CIVEIS. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. IPE-SAÚDE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. REJEIÇÃO. - Sendo o juiz o destinatário da prova, a ele incumbe a formação de seu convencimento, cabendo-lhe a condução do feito nos termos dos artigos 130 e 131, do CPC. Se, à vista das provas documentais carreadas ao feito lhe pareceu dispensável a realização de demais provas, não há cogitar de cerceamento de defesa. CONVENIADA PORTADORA DE NEOPLASIA MALIGNA DE MAMA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO: VERZENIOS (ABEMACICLIBE). APLICABILIDADE DA LEI Nº 15.145/18. PRESCRIÇÃO MÉDICA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. - O art. 4º da Lei Complementar nº 15.145/18, que revogou a Lei nº 12.134/04, dispõe que integram o plano de saúde atendimentos médicos, hospitalares, ambulatoriais, laboratoriais, bem como atos necessários ao diagnóstico e aos tratamentos, exceto os tratamentos não previstos nas tabelas do próprio Instituto (§1º). Ocorre que o entendimento jurisprudencial do STJ e deste TJRS é claro no sentido de que o plano de saúde não pode selecionar o tipo de tratamento dispensado ao segurado, com exceção daquelas que não constam do rol taxativo da ANS (EREsp nº 1.886.929/STJ). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DIREITO À SAÚDE. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. TEMA Nº 1.076 DO STJ. APLICABILIDADE DO ITEM "II" ALÍNEA "A". FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, §8º, DO CPC/15. ENTENDIMENTO DO STJ. VALOR NOMINAL. MAJORAÇÃO. - Em se tratando de*

ação em que se discute Direito à Saúde, aplica-se o disposto no item "ii" alínea "a" do Tema nº 1.076 do STJ, o qual determinação a fixação de honorários advocatícios por equidade quando o proveito econômico for inestimável. Entendimento do próprio STJ em julgados posteriores à publicação do Tema supracitado. - Valor nominal dos honorários advocatícios majorado para R$ 5.000,00 por adequação aos parâmetros utilizados por esta Câmara em situações idênticas. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO DO IPE-SAÚDE DESPROVIDA. APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA.(Apelação Cível, Nº 50007528420208210078, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em: 20-10-2022)

Assim, comprovada a indicação do tratamento, deve o réu fornecer o medicamento Pembrolizumabe, conforme a solicitação da médica assistente da parte autora.

Por fim, consigno que não há falar em ofensa aos princípios da igualdade e da isonomia, porque o mesmo tratamento deve ser alcançado a todos os participantes do plano de saúde, desde que comprovada a necessidade, já que não excluído por ele, resolvendo-se, então, a questão da obediência à legalidade, porquanto a recusa funda-se no elevado custo do tratamento e não em lei.

Registra-se, a propósito, o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado a respeito do fornecimento de tratamento de alto custo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IPERGS. DIREITO À SAÚDE. DOENÇA INTERSTICIAL FIBROSANTE PROGRESSIVA ASSOCIADA A PNEUMONITE POR HIPERSENSIBILIDADE CRÔNICA, CID 10 : J84.1. RESPONSABILIDADE DO IPE-SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ESPECÍFICO. ANTINEOPLÁSICO NINTEDANIBE 150 MG. NEGATIVA DO IPERGS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Hipótese em que o demandante é segurado do IPERGS e foi diagnosticado com doença intersticial fibrosante progressiva associada a pneumonite por hipersensibilidade crônica (CID-10 J84.1), necessitando de tratamento medicamentoso de natureza oncológica - Nintedanibe 150 mg - para controle da doença. 2. Descabe considerar legítima a negativa da Autarquia, já que, naquilo em que o Plano de Saúde oferece cobertura, entende-se que ela deve ser a mais ampla possível, lembrando que, de acordo com o art. 2º da Resolução nº 21/79 são cobertos pelo IPESAÚDE "os atendimentos médicos hospitalares, bem como os atos necessários ao diagnóstico ou tratamento" e que o art. 4º da Lei Complementar nº 15.145/2018 prevê "cobertura das despesas decorrentes dos procedimentos previstos", não se podendo admitir que o tão-só fato de a medicação prescrita não estar contida em critérios técnicos do IPE-SAÚDE seja óbice à determinação de cobertura. Precedente deste TJ/RS. 3. A falta de previsão e o alto custo do medicamento não devem servir de obstáculo ao fornecimento do tratamento postulado, visto que demonstrada a necessidade do uso do fármaco, bem como a condição de segurado da autarquia. DERAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, UNÂNIME. (Agravo de Instrumento, Nº 50388523220228217000, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em: 27-04-2022)

Desse modo, comprovada a imprescindibilidade do medicamento, a procedência do pedido é medida que se impõe.

3. Dispositivo

Com esses fundamentos, **JULGO PROCEDENTES** os pedidos iniciais, para determinar que o réu forneça ao autor o medicamento Pembrolizumabe 200mg/ml, a cada 21 dias, enquanto perdurar a necessidade do uso.

Condeno o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios ao procurador, fixados em 10% sobre o valor do tratamento, limitado ao patamar máximo de 12 meses de tratamento.

Sentença publicada e registrada eletronicamente. Agendada a intimação eletrônica das partes.

Considerando o disposto 1.010, § § 1º, 2º e 3º do CPC, interposto recurso de apelação, intime-se o apelado para contrarrazões e em seguida remeta-se ao Tribunal de Justiça. Observar a hipótese do § 2º do dispositivo citado.

Documento assinado eletronicamente por **MARCEL ANDREATA DE MIRANDA, Juiz de Direito**, em 26/11/2024, às 16:33:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10066995185v38** e o código CRC **82fdbe86**.